

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

RFL · REASONS FOR LIVING INVENTORY

Inventario de Razones para Vivir – Evaluación psicométrica multidimensional de creencias y factores cognitivo-motivacionales protectores frente al suicidio

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Reasons for Living Inventory (RFL)
Nombre en español	Inventario de Razones para Vivir
Sigla oficial	RFL
Autores originales	Marsha M. Linehan, Janet L. Goodstein, Stephen L. Nielsen y John A. Chiles (1983)
Adaptación hispanohablante	María A. Oquendo, R. Graver, Enrique Baca-García, M. Morales, V. De la Cruz y J. John Mann (2000)
Año de publicación original	1983 (adaptación al español validada en 2000)
Constructo primario	Creencias cognitivas protectoras, expectativas adaptativas y razones motivacionales para no suicidarse
Formato de administración	Autoinforme estructurado con escala ordinal Likert de 6 puntos
Población diana	Población clínica y comunitaria adulta y adolescente (≥ 16 años) con riesgo autolítico o distimia
Tiempo de aplicación	10 a 15 minutos (48 ítems autoadministrados)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto con fines no comerciales respetando citación de autoría

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

El **Inventario de Razones para Vivir** (RFL) fue concebido por Marsha M. Linehan en el marco de la terapia dialéctica conductual (DBT) y el modelo cognitivo-conductual del suicidio, partiendo de una premisa revolucionaria: la prevención del suicidio requiere no solo identificar los factores de riesgo (depresión, desesperanza, impulsividad), sino evaluar activamente la presencia y solidez de las razones que mantienen a la persona con vida (**reasons for staying alive**). La escala mide el valor protector que el paciente atribuye a diversas creencias y contingencias psicosociales al momento de considerar el suicidio.

Desde el punto de vista psicopatológico, la pérdida de razones para vivir opera como un mediador crítico entre el dolor psicológico insoportable (**psychache**) y la transición a la conducta suicida letal. En contraposición a escalas reactivas de patología, el RFL cuantifica recursos de resiliencia cognitiva agrupados en seis dominios fundamentales: expectativas de supervivencia y resolución adaptativa de crisis, vínculos y obligaciones filiales/familiares, amor y responsabilidad hacia los hijos, miedo físico al acto letal y a la muerte, preocupación por el estigma social y objeciones ético-religiosas. La versión adaptada por Oquendo et al. (2000) demostró equivalencia transcultural y alta validez discriminante entre pacientes con ideación sin tentativa frente a repetidores de tentativas.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Dimensión / Subescala	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
1. Supervivencia y Afrontamiento (SCB)	24 ítems	24 – 144	Fe en el futuro, resiliencia, esperanza y autoeficacia para superar el dolor (ítems 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, etc.)
2. Responsabilidad Familiar (RF)	7 ítems	7 – 42	Sentido de obligación, lealtad y deseo de no infligir daño psicológico a la familia (ítems 1, 7, 9, 16, 30, 47, 48)
3. Preocupación por los Hijos (CRC)	3 ítems	3 – 18	Responsabilidad parental, impacto del abandono en la crianza y bienestar de los hijos (ítems 11, 21, 28)
4. Miedo al Suicidio (FS)	7 ítems	7 – 42	Temor al dolor físico, fallo del método con secuelas invalidantes y misterio de la muerte (ítems 6, 15, 18, 26, 33, 38, 46)
5. Miedo a Desaprobación Social (FSD)	3 ítems	3 – 18	Preocupación por el juicio social, estigma público o ser visto como un fracaso (ítems 31, 41, 43)
6. Objeciones Morales (MO)	4 ítems	4 – 24	Creencias religiosas, convicciones morales y mandatos espirituales contrarios al suicidio (ítems 5, 23, 27, 34)
Puntuación Total RFL	48 ítems	48 – 288	Suma global directa o media por ítem (1-6). Mayor puntuación = mayores factores protectores.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna total	Alpha de Cronbach = 0.92 – 0.96	Excelente fiabilidad total en muestras psiquiátricas y comunitarias en España y LatAm (Oquendo et al., 2000).
Consistencia interna subescalas	Alpha = 0.72 – 0.89	SCB (0.89), RF (0.84), CRC (0.82), FS (0.81), MO (0.76), FSD (0.72). Consistencia robusta en todas las subescalas.
Fiabilidad test-retest	r = 0.75 – 0.83 (3 semanas)	Estabilidad temporal satisfactoria de las creencias protectoras fundamentales en pacientes estables.
Validez concurrente y divergente	r = –0.58 con BHS (Beck); r = –0.52 con BSS	Correlaciones inversas estadísticamente significativas con desesperanza e ideación suicida activa.
Validez discriminante	F = 38.4, p < 0.001	Diferenciación altamente significativa entre no ideadores, ideadores suicidas y pacientes con antecedentes de tentativas.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Escala de respuesta ordinal:** Cada uno de los 48 ítems se califica de 1 (**Sin ninguna importancia / No es una razón**) a 6 (**De suma importancia / Es una razón determinante**).
- **Puntuaciones directas de subescalas:** Se suman los valores brutos de los ítems pertenecientes a cada una de las 6 dimensiones. Se recomienda también calcular la media de cada subescala (suma dividida por el número de ítems del factor) para comparar la fuerza relativa de cada dominio (rango de medias: 1.0 a 6.0).
- **Puntuación Global RFL:** Suma directa de los 48 ítems (rango 48 a 288) o Media Global (rango 1.0 a 6.0).
- **Aclaración crucial en personas sin hijos:** En pacientes sin hijos, los ítems 11, 21 y 28 (Preocupación por los hijos) no son aplicables; se corrigen omitiendo dichos ítems y calculando la puntuación media sobre 45 ítems.
- **Direccionalidad psicométrica invertida a la patología:** A diferencia de las escalas sintomáticas convencionales, **a menor puntuación en el RFL, mayor vulnerabilidad y gravedad del riesgo suicida**; puntuaciones elevadas indican factores protectores robustos.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Media Ítem / Total	Nivel de Protección	Implicación Psicopatológica y Riesgo Suicida Asociado
Media ≥ 4.5 (Total > 216)	Protección Robusta / Muy Fuerte	El paciente posee convicciones vitales, lazos sociofamiliares y creencias de supervivencia plenamente funcionales. Riesgo autolítico bajo.
Media 3.5 – 4.4 (Total 168 – 215)	Protección Moderada / Estable	Razones protectoras presentes pero vulnerables ante situaciones de sobrecarga vital intensa. Requiere fortalecimiento preventivo.
Media 2.5 – 3.4 (Total 120 – 167)	Protección Débil / En Erosión	Debilitamiento grave de las creencias de supervivencia y autoeficacia. Alerta clínica: la pérdida de razones para vivir incrementa el riesgo de paso al acto.
Media < 2.5 (Total < 120)	Vacío Crítico / Protección Nula	Ausencia casi total de anclajes vitales, desesperanza terminal o alienación vincular. Riesgo suicida inminente y máximo; requiere intervención inmediata.

UMBRAL DE VULNERABILIDAD CRÍTICA: Una media en la subescala de **Supervivencia y Afrontamiento (SCB)** < 3.0 o en **Responsabilidad Familiar** < 2.5 constituye un marcador específico de colapso de las defensas cognitivas contra el suicidio, requiriendo monitorización clínica intensiva.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Aplicación y mapeo de dominios de protección:

- Administrar el RFL en conjunción con una medida de severidad de ideación (C-SSRS, BSS, RS-Plutchik). Identificar las subescalas que mantienen valores más altos (anclajes terapéuticos) y las que se encuentran colapsadas (< 2.5).

Paso 2: Estratificación según el perfil del RFL:

- **RFL Total < 120 (o SCB < 2.5):** Activar protocolo de prevención activa del suicidio. Valorar hospitalización psiquiátrica si coexiste ideación activa con intención o plan. Elaboración prioritaria del Plan de Seguridad de Stanley-Brown.
- **RFL Total 120 – 167:** Manejo ambulatorio intensivo. Focalización psicoterapéutica (DBT / TCC) en la reestructuración de la desesperanza y la reconstrucción de metas vitales significativas.
- **RFL Total > 168 con ideación residual:** Utilizar los ítems puntuados con 5 o 6 como “tarjetas de memoria de supervivencia” (**coping cards**) para las fases de crisis afectiva.

Paso 3: Integración en el Plan de Seguridad y DBT:

- Extraer literalmente las afirmaciones del RFL más valoradas por el paciente (ej. “Aún tengo curiosidad por ver qué pasará con mi vida”, “Amo a mi familia y no quiero destruirlos”) e integrarlas en el apartado de razones para vivir del plan de contingencia.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Varón de 34 años, arquitecto, en proceso de ruptura de pareja y desempleo reciente. Remitido a Salud Mental tras consultar a urgencias por crisis de angustia e ideación pasiva de muerte recurrente.

Resultados Psicofisiológicos y Puntuaciones en RFL:

- RFL Global: Media = 2.85 (Total = 137/288). Indicativo de protección en erosión severa.
- Subescala Supervivencia y Afrontamiento (SCB): Media = 2.10 (puntuaciones de 1 y 2 en capacidad para soportar el dolor o tener fe en el futuro).
- Preocupación por los Hijos: No aplica (no tiene descendencia).
- Objeciones Morales: Media = 1.75 (agnosticismo, sin frenos morales).
- **Responsabilidad Familiar (RF): Media = 4.85** (ítems 1, 7 y 9 puntuados con 5 y 6: “Mi madre depende emocionalmente de mí”, “Sé el dolor irreparable que causaría a mis hermanos”).
- Miedo al Suicidio (FS): Media = 3.40 (ambivalencia respecto al daño físico).

Interpretación y Plan Asistencial: A pesar del colapso casi total en la autoeficacia de supervivencia (SCB) y de la desesperanza situacional, el paciente conserva un núcleo de anclaje relacional muy potente centrado en la responsabilidad familiar (RF = 4.85). Se diseñó una intervención ambulatoria intensiva con TCC y módulos de DBT. Se elaboró un Plan de Seguridad estructurado centrado en su madre y hermanos como cortafuegos inmediatos, coordinando a la familia como red de soporte activo. A las 8 semanas, la media de SCB ascendió a 3.65 y el RFL total alcanzó 188 puntos, con remisión completa de la ideación autolítica.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS DE RED FLAGS AUTOLÍTICAS:

- **Puntuaciones nulas en SCB y RF simultáneamente:** La coexistencia de desconexión vincular y desesperanza absoluta es el perfil de máximo riesgo de suicidio letal.
- **Miedo al suicidio como único freno:** Si la persona solo puntúa alto en Miedo al Suicidio (FS) pero tiene 1 en todas las demás subescalas, el riesgo es elevado si el dolor psíquico supera el umbral de temor.
- **Discrepancia con la clínica:** Una aparente elevación súbita de razones para vivir en pacientes con depresión grave puede reflejar falsa complacencia tras haber tomado la decisión irrevocable de morir.

CONSIDERACIONES DIFERENCIALES:

- **RFL vs. BHS / C-SSRS:** El RFL no sustituye a la exploración directa del riesgo y letalidad; es un instrumento complementario centrado en fortalezas y resiliencia.
- **Deseabilidad social:** Pacientes en regímenes de observación pueden exagerar razones morales o familiares para evitar el ingreso involuntario.
- **Especificidad cultural:** En contextos hispanos, el peso de la responsabilidad familiar (RF) y las objeciones morales suele ser más elevado que en cohortes anglosajonas.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Linehan, M. M., Goodstein, J. L., Nielsen, S. L., & Chiles, J. A. (1983). Reasons for staying alive when you are thinking of killing yourself: The Reasons for Living Inventory. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(2), 276–286. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.51.2.276>
2. Oquendo, M. A., Graver, R., Baca-García, E., Morales, M., De la Cruz, V., & Mann, J. J. (2000). Spanish adaptation of the Reasons for Living Inventory (RFL). *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 22(3), 369–380. <https://doi.org/10.1177/0739986300223006>
3. Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.
4. Stanley, B., & Brown, G. K. (2012). Safety planning intervention: A brief intervention to mitigate suicide risk. *Cognitive and Behavioral Practice*, 19(2), 256–264. <https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2011.01.001>